

TEMA 2.3 • GINECOLOGÍA

Oligomenorrea y Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.065

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Oligomenorrea y Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

1. Oligomenorrea

Definición: Ciclos menstruales > 35 días (normal: 21–35 días).

Causas: Similares a amenorrea: **anovulación** (la más frecuente → SOP), hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hipogonadismo.

2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

Diagnóstico: ≥ 2 de los siguientes 3 criterios (Criterios de Rotterdam):

Criterio 1: Alteración Menstrual

- Amenorrea o **oligomenorrea** (ciclos > 35 días) — lo más frecuente

Criterio 2: Hiperandrogenismo

Clínico: - **Acné** - **Hirsutismo:** vello en zonas androgénicas (barba, pecho, espalda, muslos, brazos) — NO en piernas ni antebrazo (eso es normal)

- **De laboratorio:**
- **Índice de Andrógenos Libres (IAL) > 4.5**
- IAL = Testosterona / SHBG (no se mide testosterona directa)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Basta con tener **uno** de los dos (clínico O de laboratorio) para cumplir el criterio de hiperandrogenismo.

Criterio 3: Criterio Ecográfico (ECO transvaginal)

- > **12 folículos** por ovario, O - Volumen ovárico > **10 mL** por ovario

Tratamiento del SOP

- ##### 1. Resistencia a la insulina (causa principal)
- Dieta + ejercicio
- **Metformina**
- ##### 2. Hiperandrogenismo (acné, hirsutismo)
- **Anticonceptivos orales con acción antiandrogénica:**
- - Dienogest, clormadinona, drospirenona, **ciproterona** (más potente pero mayor riesgo cardiovascular → uso corto 2–3 meses)
- Depilación complementaria
- ##### 3. Infertilidad (anovulación)
- **Inductores de ovulación:**
- **Citrato de clomifeno** (bloqueador del receptor de estrógenos → elimina feedback negativo → ↑ LH)
- **Gonadotropina coriónica humana (hCG)** (simula el pico de LH)
- Análogos de GnRH (menos usados)

NOTA CLÍNICA

El pico de LH es el inductor fisiológico de la ovulación. El clomifeno lo estimula; la hCG lo simula.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Anticonceptivos proandrogénicos como **levonorgestrel** y **norgestrel** están **contraindicados** en SOP (empeoran el hiperandrogenismo). Usar los de acción antiandrogénica.

3. Otras Causas de Hiperandrogenismo / Hirsutismo

TABLA 2.3.1: CAUSA VS DIFERENCIA CON SOP

CAUSA	DIFERENCIA CON SOP
Síndrome de Cushing	Hirsutismo + acné + cara de luna, joroba de búfalo, diabetes, astenia, osteoporosis, miopatía
Hiperplasia suprarrenal congénita	Hiperandrogenismo + insuficiencia suprarrenal (hipotensión, hiperpigmentación)
Tumor virilizante adrenal	Secreta DHEA/androstenediona; virilización brusca

| **Tumor virilizante ovárico** | Secreta testosterona; virilización brusca |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 24 años consulta por ciclos menstruales irregulares de 45–60 días desde la menarquía. Refiere aumento de vello facial y acné persistente. IMC 28 kg/m². Ecografía transvaginal muestra ovarios con ≥12 folículos de 2–9 mm en cada ovario. FSH normal, LH/FSH > 2, testosterona libre levemente elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Oligomenorrea y Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. Oligomenorrea
- 2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)
- Criterio 1: Alteración Menstrual
- Criterio 2: Hiperandrogenismo
- Criterio 3: Criterio Ecográfico (ECO transvaginal)
- Tratamiento del SOP
- 3. Otras Causas de Hiperandrogenismo / Hirsutismo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OLIGOMENORREA Y SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP))**PREGUNTA 1**

Mujer de 24 años consulta por ciclos menstruales irregulares de 45-60 días desde la menarquia. Refiere aumento de vello facial y acné persistente. IMC 28 kg/m². Ecografía transvaginal muestra ovarios con ≥ 12 folículos de 2-9 mm en cada ovario. FSH normal, LH/FSH > 2, testosterona libre levemente elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío
- B)** Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
- C)** Hiperprolactinemia
- D)** Insuficiencia ovárica prematura
- E)** Hipotiroidismo

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Oligomenorrea y Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Oligomenorrea y Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: OLIGOMENORREA Y SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP)

Causas: Similares a amenorrea: anovulación (la más frecuente → SOP), hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hipogonadismo. :::tip Basta con tener uno de los dos (clínico O de laboratorio) para cumplir el criterio de hiperandrogenismo. ::: ::note El pico de LH es el inductor fisiológico de la ovulación. El clomifeno lo estimula; la hCG lo simula. :::